ACTA No. 001 -2026

FECHA REUNIÓN	06 de febrero de 2026		
LUGAR:	ESE Hospital Regional de Moniquirá		
HORA INICIO:	09:00 am	**HORA FINALIZACIÓN:**	02:00pm
RESPONSABLES:	Programa de Nutrición - Equipo IAMII		
ASISTENTES:	Se adjunta lista de asistentes.		
OBJETIVO:	Apoyar el acompañamiento a las IPS asignadas del Departamento de Boyacá para que mejoren sus prácticas de salud nutricional en el marco de la estrategia IAMII -Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral y en las normas, protocolos, procedimientos y lineamientos nacionales y departamentales y verificar la implementación efectiva de los lineamientos técnicos para la atención integral de las niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda y su respectiva ruta integral.		

ORDEN DE DÍA

1. Saludo y presentación de participantes.
2. Observación en áreas de atención.
3. Recorrido y entrevistas a colaboradores y usuarios.
4. Análisis detallado por pasos de la estrategia IAMII

DESARROLLO

1. Saludo y presentación de participantes.

En nombre de la doctora Gloria Patricia Avello referente del Programa de Nutrición de la Secretaría de Salud de Boyacá. Se realiza presentación del equipo IAMII. Se realiza concertación y aceptación con el equipo de trabajo de la agenda propuesta. La asistencia técnica contó con la participación activa del talento humano de la institución tanto asistencial como administrativo. Se indica que se realizará asistencia técnica diagnóstica a la ESE Hospital de Moniquirá basados en observacion directa en las diferentes areas de arencion y entrevistas a los profesionales, con el fin de verificar el estado actual de la implementación de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), identificar fortalezas, oportunidades de mejora, y orientar acciones de fortalecimiento institucional, de conformidad con el Lineamiento IAMII vigente, en articulación con las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) definidas en la Resolución 3280 de 2018, la normativa vigente en salud materno infantil, lactancia materna, nutrición y primera infancia.

La visita se desarrolló bajo la modalidad de asistencia técnica diagnóstica**,** conforme a lo establecido en el Lineamiento IAMII, e incluyó las siguientes estrategias metodológicas:

- Reunión de apertura con profesionales del equipo institucional iamii.
- Entrevistas a usuarias gestantes, cuidadores de niños y niñas menores de 5 años.
- Entrevistas a profesionales asistenciales.
- Observación directa de los servicios.
- Revisión de historias clínicas de urgencias y hospitalización de las áreas materno-infantil, asi como de consulta externa.
- Reunión de cierre.

2. Recorrido, observacion en areas de atencion, entrevistas, revision de historias clinicas.

Durante la apertura se informó que la visita actual se realizará bajo la modalidad de diagnóstico, con el objetivo de evaluar el estado real de la implementación de la estrategia IAMII desde la perspectiva del usuario, del colaborador y del proceso asistencial.
Se aclaró que la visita tiene un enfoque diagnóstico y formativo, no sancionatorio, orientado a identificar fortalezas y oportunidades de mejora antes de un proceso de evaluación externa.

La institución manifestó haber realizado preevaluación únicamente a usuarios, encontrándose pendiente la preevaluación a profesionales asistenciales. Se informó que el hospital se encuentra en fase de estructuración del paso 6, con intención de integrar módulos virtuales y presenciales para capacitación del talento humano.

Respecto a redes de apoyo, se indicó que estas se encuentran conformadas a nivel institucional, interinstitucional y comunitario; sin embargo, el directorio institucional se encuentra en proceso de actualización debido a cambios recientes en líderes comunitarios y juntas de acción comunal para el año 2026. Se mencionó que se proyecta su difusión mediante código QR una vez finalizada la actualización.
Asimismo, se resaltó el avance en programas complementarios como centro amigable para adolescentes, articulación con promoción y mantenimiento de la salud y trabajo intersectorial, los cuales se consideran oportunidades para fortalecer la IAMII.

Durante la visita de asistencia técnica se realizó la caracterización de la capacidad instalada, los procesos asistenciales y la percepción de usuarios y colaboradores frente a la implementación de la Estrategia IAMII en la ESE Hospital de Moniquirá.

En relación con el talento humano y la capacidad instalada, la institución cuenta con un equipo conformado por cinco (5) ginecólogos, tres (3) pediatras y tres (3) nutricionistas, lo cual permite cubrir la atención materno infantil de acuerdo con su nivel de complejidad. Adicionalmente, se identificó la existencia de un grupo de soporte nutricional, integrado por profesionales de nutrición, gastroenterología y enfermería, orientado al abordaje de casos con alteraciones del estado nutricional. No obstante, durante la visita no fue posible evidenciar de manera clara la articulación sistemática de este grupo con las rutas institucionales de atención ni su participación documentada en los procesos de seguimiento y egreso.

Respecto a las redes y procesos de articulación, la institución informó contar con redes intrainstitucionales, interinstitucionales y comunitarias conformadas; sin embargo, el directorio institucional de redes de apoyo se encuentra en proceso de actualización, debido a cambios recientes en los liderazgos comunitarios. A pesar de esta estructura, durante entrevistas se evidenció un bajo reconocimiento de las redes de apoyo tanto por parte de los colaboradores como de los usuarios, lo que limita su uso efectivo como mecanismo de continuidad del cuidado y abordaje integral de riesgos.

En el componente de usuarios, las gestantes y cuidadores de niños y niñas menores de cinco años entrevistados manifestaron no reconocer a la ESE Hospital de Moniquirá como una institución IAMII, ni identificar características diferenciales asociadas a esta estrategia. Asimismo, refirieron haber recibido mensajes inconsistentes por parte del personal de salud en relación con lactancia materna y alimentación complementaria, lo cual genera confusión y debilita la adherencia a prácticas basadas en evidencia.

En cuanto al componente de nutrición y primera infancia, se identificó que el manejo del riesgo nutricional se está realizando mediante el uso de fórmulas lácteas como Infatrini; no obstante, no se evidenció de

manera consistente el seguimiento documentado conforme a la ruta institucional de manejo de alteraciones nutricionales. Adicionalmente, se identificaron debilidades en la articulación para el egreso seguro, el seguimiento posterior y los procesos de referencia y contrarreferencia, así como falencias en los registros clínicos y antropométricos, incluyendo inconsistencias en el diligenciamiento de peso, talla y signos vitales en la atención de primera infancia.

En el componente de lactancia materna, se evidenció que los profesionales reconocen adecuadamente los signos de buen agarre y succión; sin embargo, se identificó un desconocimiento generalizado de la técnica de extracción manual de leche materna. De igual forma, se encontraron conceptos dispares entre los colaboradores respecto a los tiempos y condiciones de conservación, el transporte y el suministro de la leche materna, lo cual impacta la calidad y coherencia de la educación brindada a las usuarias.

En relación con el tamizaje neonatal, la institución realiza el tamizaje neonatal básico de manera rutinaria; no obstante, no se gestiona de forma sistemática el tamizaje neonatal ampliado, debido principalmente a barreras administrativas y de acceso asociadas a la autorización por parte de las EAPB en prestadores ubicados fuera del área de residencia de los usuarios. Se evidenció además una falta de articulación efectiva con las EAPB para garantizar el acceso oportuno y equitativo a este componente obligatorio de la atención neonatal.

Durante la reunión de cierre se expusieron los principales hallazgos identificados en entrevistas, observación directa y revisión de historias clínicas. Se manifestó preocupación por la falta de unificación de conceptos entre los profesionales, particularmente en temas críticos como lactancia materna, técnica de extracción manual, tiempos de conservación de la leche humana y recomendaciones de alimentación complementaria principalmente del area de pediatria.

Se señaló que, aunque la institución ha realizado múltiples procesos de capacitación, no se evidencia apropiación homogénea del conocimiento, incluso en servicios estratégicos como pediatría y ginecología. Se enfatizó que esta situación impacta directamente la información que reciben las usuarias y genera mensajes contradictorios.

En la revisión de historias clínicas se documentaron falencias en el diligenciamiento de signos vitales y antropometría en primera infancia, inconsistencias en el registro de talla y debilidades en la referencia y contrarreferencia para seguimiento nutricional y continuidad del cuidado.

Finalmente, se solicita de manera expresa la realización de una unidad de análisis de desnutrición aguda para un caso específico identificado con el RC 1057517871, enfatizando la necesidad de evaluar adherencia a la ruta institucional, cumplimiento al lineamiento de la Resolucion 2350 de 2020 y de la Resolución 115 de 2025, cumplimiento y adherencia del abecedario terapéutico, criterios de egreso seguro, notificaciones obligatorias y articulación intersectorial. En este caso por parte de médico de secretaria de salud se gestionó entrega de FTLC por parte de EAPB con promotora de Nueva EPS y articulación con primer nivel. Sin embargo, por parte de la institución se desconoce su articulación para el egreso notificación a entidad territorial municipal, comisaría y personería, para dar cumplimiento a la ruta de desnutrición.

Se recomienda analizar como indicador trazador la cantidad de formula lactea de recien nacidos distribuida desde farmacia versus la cantidad de recien nacidos; así mismo fortalecer el cumplimiento del codigo de sucedaneos de la leche materna.

En las instalaciones del hospital se presta el punto servicio del hospital San Rafael mas cerca a la comunidad, quienes manifiestan no conocer la dinamizacion de la estrategia IAMII en el hospital de Moniquirá como tampoco han sido informados acerca de las acciones que se adelantan en la institucion.

Análisis detallado por pasos de la estrategia IAMII

Paso 1. Política institucional IAMII

Hallazgos: La ESE Hospital de Moniquirá cuenta con un comité IAMII y reconoce formalmente la estrategia dentro de su gestión institucional. No obstante, durante entrevistas a usuarios se evidenció desconocimiento generalizado de la estrategia IAMII, principalmente en el servicio de urgencias y consulta externa.

Análisis normativo: El Lineamiento IAMII vigente establece que la política institucional IAMII debe ser explícita, documentada, visible, socializada y conocida por todo el talento humano y la comunidad usuaria, constituyéndose en un eje de garantía de derechos, humanización de la atención y gestión institucional.

Oportunidad de mejora

- Socializar la estrategia IAMII a todo el talento humano y usuarios, incluidos servicios de apoyo; incluir en plan de medios institucional.
- Garantizar su visibilización y socialización permanente en áreas de ingreso y atención
- IAMII debe integrarse a: habilitación, PAMEC, auditoría para el mejoramiento de la calidad, comités de calidad y seguridad del paciente, humanización, sistemas de información y gestión documental. Esta integración favorece decisiones basadas en datos, reduce duplicidades y fortalece la trazabilidad institucional.

Paso 2. Capacitación del talento humano

Hallazgos: Aunque la institución ha realizado procesos de capacitación, se evidenció falta de homogeneidad en conocimientos y prácticas, particularmente en pediatría, ginecología, enfermería y medicina general, en temas críticos como lactancia materna, extracción manual, conservación de leche humana y alimentación complementaria.

Análisis normativo: El Lineamiento IAMII vigente y la Resolución 3280 de 2018 exigen que todo el talento humano que atiende población materno infantil cuente con competencias actualizadas, evaluables y basadas en evidencia, articuladas con las RIAS.

Oportunidad de mejora

- Fortalecer y dar cumplimiento al plan institucional de capacitación IAMII el cual debe estar armonizado con el plan de capacitación institucional.
- El área de calidad debe evaluar permanentemente las competencias adquiridas, respecto a los temas que plantea la estrategia IAMII y las RIAS.
- Realizar talleres teórico prácticos sobre los temas críticos evidenciados.

Paso 3. Información, educación y comunicación a usuarios

Hallazgos: Las usuarias gestantes y cuidadores de niños menores de cinco años refieren no reconocer a la institución como IAMII y recibir información inconsistente sobre prácticas de lactancia materna y alimentación infantil.

Análisis normativo: El Lineamiento IAMII vigente establece que la educación debe ser clara, coherente, continua y basada en evidencia, garantizando decisiones informadas y protección del derecho a la salud.

Oportunidad de mejora

- Estandarizar mensajes educativos institucionales.
- Capacitar al personal de primer contacto.
- Integrar educación IAMII desde el ingreso del usuario.

Paso 4. Atención amigable, cálida y humanizada

Hallazgos: Destaca que es la única IPS del departamento con la menor proporción de cesáreas dando cumplimiento a los estándares de la OMS. Durante entrevistas, los usuarios destacaron buen trato y calidez humana; sin embargo, la falta de reconocimiento del enfoque IAMII limita la consolidación de una atención plenamente humanizada bajo el modelo de la estrategia.

Análisis normativo: El Lineamiento IAMII vigente señala que la atención humanizada debe ser intencional, sistemática y reconocible por el usuario, articulada con la Política de Atención Integral en Salud.

Oportunidad de mejora

- Incorporar el enfoque IAMII en la inducción y reinducción del personal.
- Fortalecer la comunicación empática y educativa durante la atención.

Paso 5. Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna

Hallazgos: Se evidenció reconocimiento de signos de buen agarre y succión; sin embargo, existe desconocimiento de la técnica de extracción manual, así como conceptos dispares sobre conservación, transporte y suministro de leche materna.

Análisis normativo: El Lineamiento IAMII vigente, las recomendaciones OMS/UNICEF y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos establecen la obligación de proteger activamente la lactancia materna y garantizar información basada en evidencia.

Oportunidad de mejora

- Capacitar al talento humano en técnica de extracción manual de leche materna.
- Socializar guías UNICEF sobre manejo de leche humana.
- Actualizar protocolos institucionales.

Paso 6. Uso adecuado de sucedáneos de la leche materna

Hallazgos: Se identificó uso de fórmulas lácteas en manejo nutricional sin evidencia clara de monitoreo sistemático del cumplimiento del Código de Sucedáneos ni análisis institucional de tasas de uso.

Análisis normativo: El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos y el Lineamiento IAMII vigente prohíben la promoción inadecuada de fórmulas y exigen vigilancia institucional.

Oportunidad de mejora

- Implementar monitoreo periódico del uso de fórmulas.
- Analizar y enviar tasa de uso de fórmula vs nacimientos institucionales.
- Fortalecer control interno del cumplimiento del Código.

Paso 7. Alimentación complementaria saludable

Hallazgos: Pediatría y otros profesionales no brindan recomendaciones alineadas con las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS) y la evidencia actual, generando mensajes contradictorios a los cuidadores.

Análisis normativo: La Resolución 3280 de 2018 y el Lineamiento IAMII vigente exigen que la alimentación complementaria se oriente conforme a GABAS y evidencia científica vigente.

Oportunidad de mejora

- Capacitar al talento humano en GABAS actualizadas.
- Estandarizar recomendaciones institucionales.
- Integrar educación alimentaria en controles de crecimiento y desarrollo.

Paso 8. Atención integral a la primera infancia

Hallazgos: En revisión de historias clínicas se evidenció registro incompleto de signos vitales y antropometría, inconsistencias en talla y debilidades en el seguimiento integral.

Análisis normativo: La Resolución 2465 de 2016 establece estándares para la valoración antropométrica; la Resolución 3280 de 2018 exige integralidad y continuidad del cuidado.

Oportunidad de mejora

- Fortalecer auditoría clínica de historias.
- Garantizar equipos antropométricos de acuerdo la normativa vigente y uso adecuado de los mismos en todos los consultorios.
- Reforzar valoración integral en cada consulta.

Paso 9. Protocolos

Hallazgos: El manejo del riesgo nutricional se realiza con fórmulas como Infatrini, sin evidencia clara de adherencia documentada a la ruta institucional. Se identifican falencias en egreso seguro en primera infancia y notificación intersectorial en casos de desnutrición.

Análisis normativo: La Resolución 2350 de 2020 y su actualización 2026 establecen la ruta integral para la atención de la desnutrición aguda, incluyendo seguimiento, egreso seguro y notificación obligatoria.

Oportunidad de mejora

- Realizar unidad de análisis de casos.
- Revisar y socializar la ruta institucional de desnutrición.
- Fortalecer articulación con EAPB y entidades territoriales.

Paso 10. Articulación y redes de apoyo

Hallazgos: Se identifican avances en articulación interinstitucional; sin embargo, persisten debilidades en seguimiento post egreso, referencia y contrarreferencia, y sostenibilidad operativa de la estrategia.

Análisis normativo: El Lineamiento IAMII vigente establece que la estrategia debe contar con mecanismos de seguimiento, evaluación y sostenibilidad articulados con el SOGCS y el PAMEC.

Oportunidad de mejora

- Formalizar indicadores de seguimiento IAMII.
- Integrar la estrategia al PAMEC institucional.

- Garantizar continuidad del cuidado mediante referencia efectiva.
- Establecer y socializar con usuarios y colaboradores las redes de apoyo actuales.

COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	META	PLAZO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
1	Socializar y visibilizar de manera institucional la Estrategia IAMII a todo el talento humano, servicios de apoyo y usuarios, integrándola al plan de medios institucional y a los procesos de inducción y reinducción.	Estrategia IAMII socializada al 100 % del talento humano y visibilizada en áreas de ingreso y atención; usuarios informados sobre el enfoque IAMII.	3 meses	Gerencia ESE Hospital de Moniquirá; Coordinación de Calidad; Comité IAMII	Junio de 2026	Equipo IAMII
2	Fortalecer las competencias del talento humano mediante la ejecución del plan institucional de capacitación IAMII, con talleres teórico-prácticos en lactancia materna (incluida extracción manual), manejo de leche humana y alimentación complementaria basada en GABAS.	≥90 % del talento humano asistencial capacitado y evaluado en competencias críticas IAMII.	4 meses	Coordinación de Talento Humano; Comité IAMII; Jefes de Servicio	Julio de 2026	Equipo IAMII
3	Revisar, socializar y garantizar la adherencia a la ruta institucional de manejo del riesgo nutricional y la desnutrición; realizar la unidad de análisis del caso RC 1057517871 conforme a la normativa vigente.	Ruta institucional actualizada y socializada; unidad de análisis realizada y plan de mejora definido; mejora en registros clínicos y antropométricos.	2 meses	Coordinación de Servicios Asistenciales; Grupo de Soporte Nutricional; Comité IAMII	Mayo de 2026	Equipo IAMII
4	Actualizar y socializar el directorio de redes de apoyo y fortalecer la articulación interinstitucional, referencia-contrarreferencia y seguimiento post egreso, incluyendo gestiones con EAPB para tamizaje neonatal ampliado.	Directorio de redes actualizado y socializado; mecanismos de seguimiento post egreso implementados; articulación documentada con EAPB.	3 meses	Coordinación de Calidad; Trabajo Social; Comité IAMII	Junio de 2026	Equipo IAMII

OBSERVACIONES

Se recomienda dar cumplimiento a las oportunidades de mejora establecidas. Se concreta por parte de comité IAMII institucional realizar plan de choque de acuerdo con estas oportunidades de mejora y plantean próxima visita para la fecha de 24 de marzo de 2026 para dar seguimiento al mismo.

La implementación de la estrategia IAMII al ser una estrategia nacional adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), orientada a proteger, promover y apoyar una atención integral, humanizada y de alta calidad; debe evaluarse permanentemente desde el área de calidad, donde se logre evidenciar que las prácticas diarias en la atención son basadas en evidencia y estándares de calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS), en el marco de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal (RIAMP) y la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RPMS), como componentes esenciales del modelo de atención.

Se adjunta listados de asistencia.